Migraña y Mujer

JOSEFINA HERNÁNDEZ RUIZ

R2 MFYC

INDICE

- Introducción
- Migraña y Anticoncepción
- Migraña en el embarazo
- Migraña en la lactancia
- Conclusiones
- Bibliografía

1. Introducción

- La migraña es **dos veces** más común en mujeres que en hombres tras la pubertad.
- Prevalencia en infancia: Niñas = Niños.

<u>Factores predisponentes</u>:

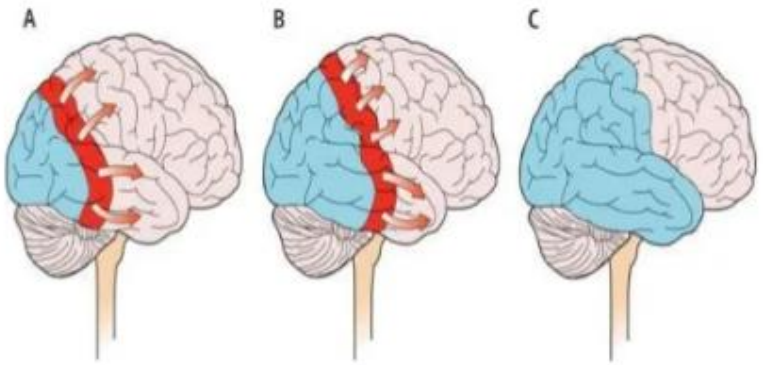
- ❑ Menstruación

*Ataques de migraña más prolongados y con menor respuesta a Triptanes.

- ❑ Menarquia
- ❑ Embarazo
- ❑ Menopausia
- ❑ Uso de fármacos anticonceptivos o de THS.

2. Migraña y Anticoncepción

- En 1996, Lichten describió cómo la administración de estradiol desencadenaba migraña en mujeres que previamente habían descrito episodios de **migraña menstrual (MM).**
- Se ha demostrado en modelos animales que niveles altos de estrógenos incrementan la susceptibilidad al **mecanismo de la depresión cortical propagada.** Se explicaría así la mayor prevalencia de migraña con aura (MCA) durante la gestación, y el hecho de que la migraña durante la menstruación tan solo en raras ocasiones asocie aura.
- Finalmente, sabemos que las pacientes con migraña tienen una caída más rápida de los niveles de estrógenos durante los 5 días siguientes al pico luteínico.



2. Migraña y Anticoncepción

Tabla 1. Criterios diagnósticos de la migraña menstrual y migraña relacionada con la menstruación según la CIC-3[4]
Migraña menstrual pura sin aura
A. Crisis, en mujer con menstruación[1], que cumplen los criterios de migraña sin aura y el criterio B B. Existen evidencias documentadas y registradas de manera prospectiva durante como mínimo tres ciclos menstruales consecutivos que confirman que las crisis se producen únicamente en el día 1 ± 2 (p. ej., de los días −2 a +3)[2] de la menstruación[1] en al menos dos de los tres ciclos y en ningún otro momento del mismo
Migraña relacionada con la menstruación
A. Crisis, en mujer con menstruación[1], que cumplen los criterios de migraña sin aura y el criterio B B. Existen pruebas documentadas y registradas de manera prospectiva durante como mínimo tres ciclos menstruales consecutivos que confirman que las crisis se producen en el día 1 ± 2 (p. ej., de los días −2 a +3)[2] de la menstruación[1] en al menos dos o de los tres ciclos y en otros momentos del ciclo

2.1 Tipos de anticonceptivos

- No hormonales.
- Hormonales (E+P): Riesgo cardiovascular.

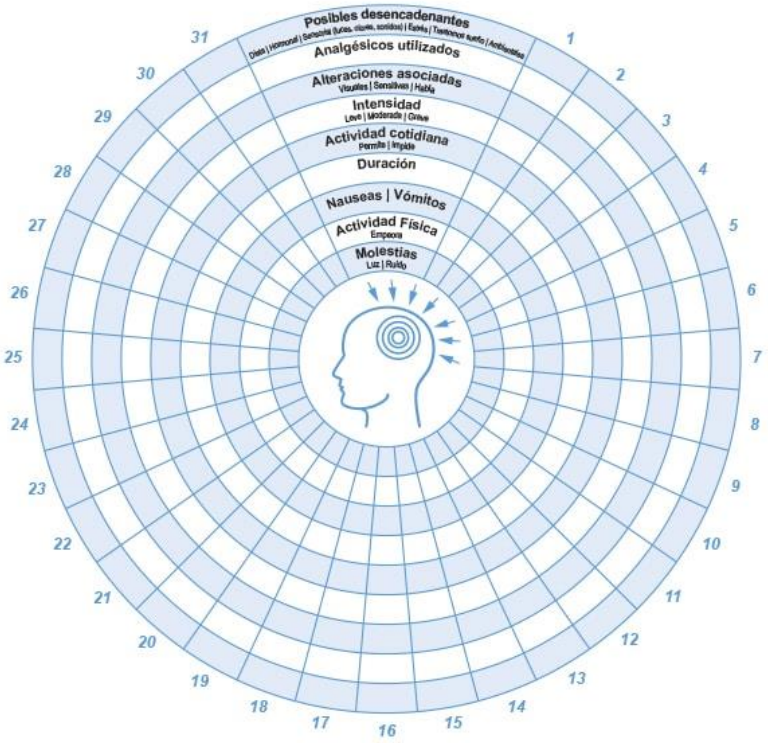
*Ojo en mujeres con migraña y riesgo vascular.

RIESGO ABSOLUTO DE ICTUS ISQUÉMICO	Mujeres 20-44 años sin migraña	Migraña sin aura (MSA)	Migraña con aura (MCA)
Tratamiento ACHO	6,3/100 000	25,4/100 000	36,9/100 000
Sin ACHO	2,5/100 000	4/100 000	5,9/100 000

2.2 ¿Qué anticonceptivo se recomienda?

Antes de iniciar tratamiento:

- Anamnesis detallada de su migraña.
- Existencia de Aura.
- Factores de riesgo vascular.



2.2 ¿Qué anticonceptivo se recomienda?

	MCA	MSA
Sin FRV	• Anticoncepción no hormonal (preservativo, DIU de cobre). • Solo con progesterona (comprimido, implante subdérmico, inyección depot, o DIU liberador de levonorgestrel)	• Anticoncepción hormonal combinada con ≤35mcg de etinilestradiol. + control estricto de la migraña y la frecuencia de los ataques.
Con FRV (Tabaquismo, obesidad, HTA, antecedente de TVP, embolismo pulmonar o enfermedad cardiovascular)	• Desogestrel 75 mcg/día *mejora la migraña relacionada con la menstruación y puede mejorar la migraña fuera del ciclo menstrual.	• Anticoncepción no hormonal. • Solo con progesterona.
SOP y/o Endometriosis	• T. hormonal combinado o solo con progesterona	• T. hormonal combinado o solo con progesterona

Situaciones especiales.

1. Cefalea atribuida a hormonas exógenas.
2. Cefalea por supresión de estrógenos.

Tabla 2. Criterios diagnósticos de la cefalea por supresión de estrógenos según la CIC-3[4]

Cefalea por supresión de estrógenos
A. Cefalea o migraña que cumple el criterio C B. Consumo diario de estrógenos durante ≥3 o más semanas que es interrumpido C. La causalidad queda demostrada mediante los dos criterios siguientes: • La cefalea o migraña se desarrolla dentro de los 5 días siguientes al último consumo de estrógenos • La cefalea o migraña se resuelve dentro de los 3 días siguientes a su aparición D. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la clasificación

Situaciones especiales.

1. Cefalea atribuida a hormonas exógenas.
2. **Cefalea por supresión de estrógenos.**

Tabla 2. Criterios diagnósticos de la cefalea por supresión de estrógenos según la CIC-3[4]
Cefalea por supresión de estrógenos
A. Cefalea o migraña que cumple el criterio C B. Consumo diario de estrógenos durante ≥3 o más semanas que es interrumpido C. La causalidad queda demostrada mediante los dos criterios siguientes: • La cefalea o migraña se desarrolla dentro de los 5 días siguientes al último consumo de estrógenos • La cefalea o migraña se resuelve dentro de los 3 días siguientes a su aparición D. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la clasificación

3. Migraña en el Embarazo

- Mejoría de la frecuencia e intensidad en **2° y 3° Trimestre** (MSA>MCA).
- **Aura** puede aparecer por 1ª vez en el embarazo (⇧ Niveles de Estrógenos que facilitan la depresión cortical propagada).

Tratamiento en el Embarazo

3.1. Tratamiento sintomático en Embarazo

Intensidad **LEVE-MODERADA**:

- **Paracetamol**: de elección. *Alt. Neurodesarrollo y respiratorio.*
- AINE: Ibuprofeno es el más seguro. *Riesgo de aborto en 1 trimestre y algunas malformaciones congénitas (paladar hendido o cardiovasculares).* Contraindicado a partir de la semana 30 por Riesgo de cierre precoz del ductus arterioso.
- Metoclopramida: opción segura para náuseas o la hiperémesis gravídica.

Intensidad **GRAVE y/o no responden** :

- **Sumatriptán**: el único seguro.

Review > Headache. 2015 Apr;55(4):490-501. doi: 10.1111/head.12500. Epub 2015 Feb 3.

Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis

Alexander Marchenko [1], Fatma Etwel, Olukayode Olutunfese, Cheri Nickel, Gideon Koren, Irena Nulman

Results: One case-control study and 5 cohort studies met the inclusion criteria. The included studies provided information on duration of gestation, major congenital malformations, and spontaneous abortions of infants following prenatal triptan exposure. The 6 studies included 4208 infants of women who used sumatriptan or other triptan medications, and 1,466,994 children of women who did not use triptans during pregnancy. No significant increases in rates for major congenital malformations (MCMs), prematurity, or spontaneous abortions were found when comparing the triptan-exposed group to the migraine - no triptans control group (odds ratio [OR] = 0.84 [0.61-1.16]; OR = 0.90 [0.35-2.30]; OR = 1.27 [0.58-2.79], respectively). There were no increased rate of MCMs (OR = 1.18 [0.97-1.44]) or prematurity (OR = 1.16 (0.67-1.99) when the triptan-exposed group was compared with the healthy controls; however, there was a significant increase in the rates of spontaneous abortions (OR = 3.54 [2.24-5.59]). When the migraine no-triptan group was compared with healthy controls, a significant increase in the rates of MCMs was found (OR = 1.41 [1.11-1.80]).

Conclusion: The use of triptans during pregnancy does not appear to increase the rates for MCMs or prematurity. The increased rates of spontaneous abortions in the triptan-exposed group and the increased rates of MCM in the migraine no-triptan group require further research.

3.2. Tratamiento preventivo en Embarazo

Se deben evitar durante 1er trimestre (Mayor riesgo de teratogenicidad).

- **Propanolol:** de primera línea. *Riesgo de retraso de crecimiento intrauterino y de bradicardia, hipotensión e hipoglucemia fetal.*
- Magnesio oral: ¡controversia!
- Bloqueos anestésicos del N. occipital (Lidocaína): muy buena opción por su eficacia y seguridad.
- Amitriptilina a dosis bajas: tratamiento de segunda línea.
- Toxina botulínica: en pacientes que ya estuvieran previamente recibiéndola por migraña crónica. No se recomienda iniciar en el embarazo.
- Nuevas moléculas frente al péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), concretamente los anticuerpos monoclonales: contraindicados durante el embarazo y la lactancia. Se recomienda antes de iniciar la gestación un periodo de lavado de 5 vidas medias.

4. Migraña en la lactancia

- Varios trabajos han atribuido cierto papel protector a la lactancia materna, aunque muchas pacientes empeoran. Esto se podría justificar por el efecto anovulatorio de la prolactina que mantiene niveles de estrógenos más estables y cierto papel anti nociceptivo de la oxitocina y prolactina.
- Durante el puerperio la mayoría de pacientes empeora, lo que puede suponer **mayor necesidad de tratamiento** que durante la gestación.

e-lactancia

Tratamiento durante la lactancia

4.1. Tratamiento sintomático en Lactancia

Intensidad **LEVE-MODERADA**:

- **Paracetamol**: de elección.
- AINE: Ibuprofeno es el más seguro. Menor excreción en la leche materna y el más estudiado en lactantes.
- Metoclopramida o Domperidona: para náuseas.

*Con la metoclopramida se han descrito reacciones extrapiramidales en los lactantes y al aumentar la prolactina puede aumentar la producción de leche materna.

Intensidad **GRAVE y/o no responden** :

- **Sumatriptán.**
- **Eletriptán.**

4.2. Tratamiento preventivo en Lactancia

Durante el puerperio y la lactancia las opciones son similares.

- **Bloqueos anestésicos:** son una de las opciones más seguras y cómodas para las pacientes.
- **Propanolol:** de primera línea. Vigilar si *hipoglucemia del lactante*.
- Magnesio y Ribloflavina.
- Amitriptilina a dosis bajas: se excreta en cantidades muy bajas. Se debe vigilar la aparición de *somnolencia*.
- Toxina botulínica tipo A: no está bien establecida su seguridad, aunque probablemente no se excrete en leche.
- Nuevas moléculas frente al péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), concretamente los anticuerpos monoclonales: contraindicados durante el embarazo y la lactancia.

5. Conclusiones

I. La migraña es dos veces más común en mujeres que en hombres a partir de la pubertad, a medida que éstas comienzan a experimentar cambios hormonales.

II. En mujeres que quieren iniciar un tratamiento anticonceptivo hormonal, debe realizarse una detallada anamnesis de su migraña, valorar la existencia de aura y de factores de riesgo vascular.

III. La administración habitual de hormonas puede asociarse al incremento en la frecuencia o intensidad de una migraña de base o a la aparición de una nueva cefalea.

IV. La decisión del uso de fármacos durante el embarazo se evaluará de forma individual en cada paciente sabiendo que ninguna opción está exenta de riesgos.

Bibliografía

- Lichten EM. Menstrual migraine and treatment options. Headache 2018; 58: 145-6.
- Sances G, Granella F, Nappi RE, Fignon A, Ghiotto N, Polatti F, et al. Course of migraine during pregnancy and postpartum: A prospective study. Cephalalgia. 2003;23(3):197-205.
- Todd C, Lagman-Bartolome AM, Lay C. Women and Migraine: the Role of Hormones. Curr Neurol Neurosci Rep. 2018;18(7):1-6.
- Noseda R, Bedussi F, Gobbi C, Ceschi A, Zecca C. Safety profile of monoclonal antibodies targeting the calcitonin gene-related peptide system in pregnancy: Updated analysis in VigiBase. Cephalalgia. 2023;43(4).

¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!